Observatorio de Cáncer | POR UN PERÚ SIN CÁNCER.

WWW.PORUNPERUSINCANCER.COM

@PORUNPERUSINCANCER

Observatorio de Cáncer | POR UN PERÚ SIN CÁNCER.

LA RUTA DE LA PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA

Del **primer signo** al inicio del tratamiento: una **investigación sobre los** ***tiempos de espera, las barreras y las experiencias de las pacientes***

2026

Una investigación para conocer las experiencias de las pacientes, identificar barreras y comprender los tiempos que marcan el recorrido hacia la atención oncológica.

LA RUTA DE LA PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA

La Ruta de la Paciente con Cáncer de Mama es una investigación **impulsada por Por Un Perú Sin Cáncer,** a través de su **Observatorio Oncológico**, para conocer la experiencia de las pacientes desde la **primera señal** o hallazgo hasta el **inicio del tratamiento**. El estudio explora los *tiempos de espera*, el *acceso a exámenes* y *resultados*, las *derivaciones*, las *dificultades durante el recorrido* y la *información que reciben* las pacientes. El propósito es **aportar evidencia** basada en la experiencia de las pacientes para **identificar puntos críticos de la atención y contribuir** a la conversación pública sobre **oportunidades de mejora** en el *diagnóstico y el acceso oportuno al tratamiento.*

FICHA TÉCNICA

612 MUESTRA TOTAL

485 SISTEMA PÚBLICO

127 SISTEMA PRIVADO

Nombre	La Ruta de la Paciente con Cáncer de Mama
Responsable	Observatorio Oncológico de Por Un Perú Sin Cáncer
Tipo de estudio	Encuesta descriptiva
Muestra total	612 registros
Unidad de análisis	Respuestas de participantes sobre su recorrido de atención
Público	MINSA 182; EsSalud 282; FF. AA. 21
Privado/particular	Seguro privado 110; atención particular 17
Periodo de investigación	Del 01 de Septiembre al 16 de Octubre
Ámbito geográfico	Lima 292 (47,7%), Arequipa 93 (15,2%), Piura 76 (12,4%), La Libertad 57 (9,3%), Junín 53 (8,7%) y Lambayeque 41 (6,7%)

UNA RUTA QUE NO TERMINA CON EL DIAGNÓSTICO

El camino de una paciente con cáncer de mama comprende **varias etapas**. En cada una puede necesitar **citas**, **pruebas**, **resultados**, **derivaciones** e **información** para avanzar al siguiente paso de su **atención**

Para comprender el acceso al tratamiento, no basta con conocer cuándo se diagnostica una enfermedad. También es necesario entender cuánto tarda cada etapa y qué obstáculos enfrenta la paciente.

1. **PRIMERA SEÑAL** — Reconocer un cambio o hallazgo y decidir buscar atención
2. **PRIMERA CONSULTA** — Acceder a una evaluación médica
3. **EXÁMENES Y RESULTADOS** — Realizarse las pruebas indicadas y recibir los resultados
4. **BIOPSIA Y DIAGNÓSTICO** — Confirmar el diagnóstico y conocer la información clínica
5. **ESTUDIOS Y DERIVACIONES** — Completar evaluaciones y organizar la atención especializada
6. **INICIO DEL TRATAMIENTO** — Acceder al tratamiento indicado por el equipo médico

Observatorio de Cáncer | POR UN PERÚ SIN CÁNCER.

LA RUTA DE LA PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA

¿DÓNDE SE PRODUCEN LAS ESPERAS Y QUÉ BARRERAS DIFICULTAN EL ACCESO AL TRATAMIENTO?

EN BASE A RESULTADOS DEL SISTEMA PÚBLICO

1. DIFICULTADES PARA **REALIZAR EXÁMENES** — **67,0 %**
2. ETAPA DE MAYOR ESPERA: **EXÁMENES** — **25,6 %**
3. PRINCIPAL DIFICULTAD: **CONSEGUIR UNA CITA** — **28,9 %**
4. ACUDIÓ AL SECTOR PRIVADO BUSCANDO **RAPIDEZ** — **46,9 %**
5. **RETRASOS** EN EL INICIO DEL TRATAMIENTO — **69,5 %**
6. REALIZAR LOS EXÁMENES: **PRINCIPAL DIFICULTAD DIAGNÓSTICA** — **17,7%**
7. ESPERAR RESULTADOS — **14,8 %**

CONCLUSIONES GENERALES

La evidencia recogida por el Observatorio de Cáncer de Por Un Perú Sin Cáncer muestra que la experiencia de una paciente con cáncer de mama no se limita a recibir un diagnóstico: también depende de su capacidad para acceder a citas, completar exámenes, obtener resultados, avanzar entre servicios y comenzar el tratamiento.
Los hallazgos identifican oportunidades de mejora en la oportunidad de la atención, la disponibilidad de recursos diagnósticos, la coordinación entre servicios y la información que reciben las pacientes. Incorporar su experiencia en la evaluación de los servicios de salud es fundamental para identificar puntos críticos y orientar acciones concretas de mejora.

LA RUTA HACIA EL TRATAMIENTO TAMBIÉN IMPORTA. DETECTAR LAS BARRERAS QUE ENFRENTAN LAS PACIENTES ES UN PASO NECESARIO PARA AVANZAR HACIA UNA ATENCIÓN ONCOLÓGICA MÁS OPORTUNA, CONTINUA Y CENTRADA EN SUS NECESIDADES

2

El acceso a exámenes y la disponibilidad de citas constituyen puntos críticos de la atención

Los exámenes fueron la etapa identificada con mayor frecuencia como aquella en la que se experimentaron más esperas: 147 participantes (24,0%) los señalaron como el principal punto de demora. Asimismo, conseguir una cita fue la dificultad más mencionada durante el recorrido, con 140 respuestas entre las 608 válidas para esta pregunta (23,0%). Estos resultados apuntan a la necesidad de revisar la disponibilidad de citas, equipos y personal especializado, así como los tiempos entre la solicitud de una prueba y la obtención de sus resultados.

24,0 %
SEÑALARON LOS EXÁMENES COMO EL PRINCIPAL PUNTO DE DEMORA

23,0 %
MENCIONARON QUE CONSEGUIR UNA CITA FUE LA PRINCIPAL DIFICULTAD

3

Las experiencias reportadas muestran diferencias relevantes entre el sistema público y el privado

Entre las 485 participantes que declararon cobertura en el MINSA, EsSalud o las Fuerzas Armadas, el 67,0% reportó dificultades para realizarse exámenes y el 69,5% señaló retrasos en el inicio del tratamiento. En el grupo privado o particular, conformado por 127 participantes, las principales dificultades mencionadas fueron obtener autorizaciones (23,6%) y afrontar los costos (19,7%). Los resultados muestran que las barreras adoptan distintas formas según el sistema de atención declarado y que las soluciones deben responder a las necesidades específicas de cada contexto.

SISTEMA PÚBLICO

67,0 % REPORTÓ DIFICULTADES PARA REALIZARSE EXÁMENES

69,5 % SEÑALÓ RETRASOS EN EL INCIO DEL TRATAMIENTO

SISTEMA PRIVADO

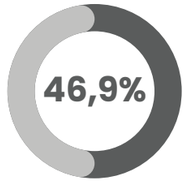
23,6% MENCIONÓ DIFICULTADES PARA OBTENER AUTORIZACIONES

19,7 % SEÑALÓ QUE EL PRINCIPAL DESAFÍO FUE AFRONTAR LOS COSTOS

4

Las experiencias reportadas muestran diferencias relevantes entre el sistema público y el privado

Entre las participantes que declararon pertenecer al sistema público y respondieron esta pregunta, 227 de 484 (46,9%) indicaron haber acudido al sector privado buscando una atención más rápida. Este hallazgo evidencia el uso complementario del sector privado por parte de un grupo importante de participantes. También plantea la necesidad de investigar qué servicios motivan esta decisión, cuánto representa el gasto de bolsillo y cómo garantizar que el acceso a exámenes y tratamientos oportunos no dependa de la capacidad de pago de las pacientes.

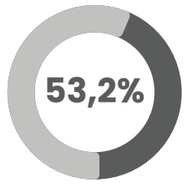


ACUDIERON AL SECTOR PRIVADO BUSCANDO ATENCION MÁS RÁPIDA

5

Las experiencias reportadas muestran diferencias relevantes entre el sistema público y el privado

La ruta hacia el tratamiento requiere que las pacientes sepan cuál es el siguiente paso, qué evaluaciones necesitan y cómo continuar su atención. Sin embargo, en el grupo público, 258 de 485 participantes (53,2%) respondieron que nunca recibieron información clara sobre el siguiente paso. Esta situación refuerza la importancia de mejorar la comunicación entre los servicios de salud, la orientación durante las derivaciones y el acompañamiento para facilitar la continuidad de la atención.



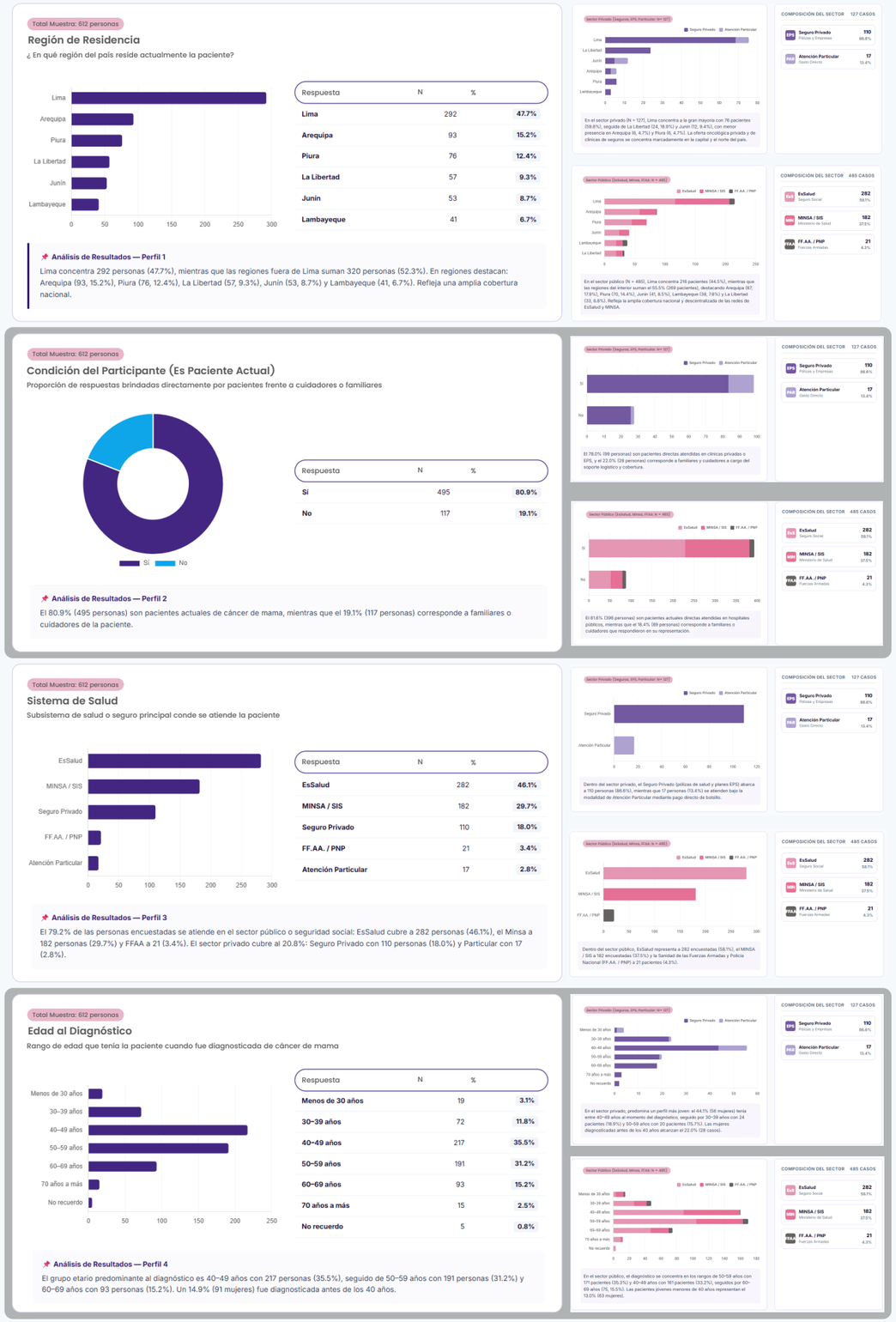
NUNCA RECIBIERON INFORMACIÓN CLARA SOBRE EL SIGUIENTE PASO

6

Las experiencias reportadas muestran diferencias relevantes entre el sistema público y el privado

La base registra diferencias entre el estadio declarado inicialmente y el referido al inicio del tratamiento en un grupo de participantes. Estos resultados justifican profundizar en la oportunidad del diagnóstico, los tiempos de atención y la continuidad del tratamiento. Sin embargo, las respuestas de la encuesta, por sí solas, no permiten afirmar que las demoras hayan causado una progresión de la enfermedad. Antes de formular conclusiones clínicas, es necesario validar la información y su temporalidad con especialistas.

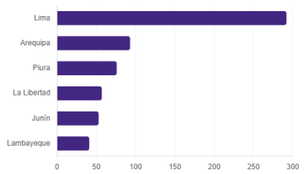
Observatorio de Cáncer | POR UN PERÚ SIN CÁNCER.



Total Muestra: 612 personas

Lugar de diagnóstico

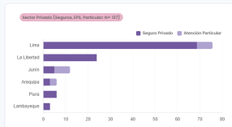
Región donde se realizó el diagnóstico inicial del cáncer de mama



Respuesta	N	%
Lima	292	**47.7%**
Arequipa	93	**15.2%**
Piura	76	**12.4%**
La Libertad	57	**9.3%**
Junín	53	**8.7%**
Lambayeque	41	**6.7%**

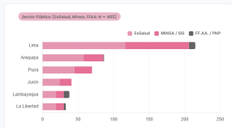
Análisis de Resultados — Pregunta 1

Lima concentra 292 personas (47.7%), mientras que las regiones fuera de Lima suman 320 personas (52.3%). En regiones destacan: Arequipa (93, 15.2%), Piura (76, 12.4%), La Libertad (57, 9.3%), Junín (53, 8.7%) y Lambayeque (41, 6.7%).



El 59.8% (76 personas) se diagnosticó en establecimientos privados de Lima, seguida de centros clínicos en La Libertad (24, 18.9%), Junín (12, 9.4%) y Arequipa (6, 4.7%).





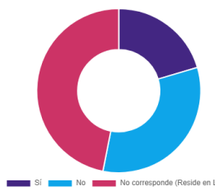
El 44.5% (216 personas) fue diagnosticada en Lima. En regiones públicas destacan Arequipa (87, 17.9%), Piura (70, 14.4%), Junín (41, 8.5%), Lambayeque (38, 7.8%) y La Libertad (33, 6.8%), donde la confirmación diagnóstica se logró en hospitales locales de EsSalud y MINSA.



Total Muestra: 612 personas

Derivada a Lima

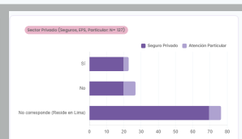
¿Tuve que ser derivada o trasladada a Lima durante su atención?



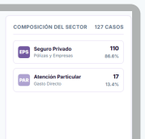
Respuesta	N	%
Sí	125	**20.4%**
No	200	**32.7%**
No corresponde (Reside en Lima)	287	**46.9%**

Análisis de Resultados — Pregunta 2

125 personas (20.4% del total encuestado; 38.5% de quienes residen en regiones) requirieron ser trasladadas a Lima para diagnóstico o tratamiento, mientras que 200 no lo requirieron y 287 ya residían en Lima.



Entre las 50 pacientes privadas de regiones, 23 requirieron trasladó a Lima (46.0% de quienes residen en provincias; 18.1% del total privado), principalmente por falta de infraestructura de radioterapia o cirugías de alta complejidad en su localidad.





Entre las 275 pacientes públicas de regiones, 102 personas (37.1% de quienes viven en regiones; 21.0% del total público) requirieron ser derivadas o trasladadas a Lima para acceder a confirmación o tratamiento especializado; 173 resolvieron su atención en su región y 210 ya residían en Lima.



Total Muestra: 612 personas

Etapa de derivación a Lima

Etapa del recorrido en que fue necesario el traslado a Lima



Respuesta	N	%
Confirmación del diagnóstico / biopsia	49	**8.0%**
Estudios para determinar el estadio	4	**0.7%**
Consulta con especialista	20	**3.3%**
Cirugía	10	**1.6%**
Quimioterapia	18	**2.9%**
Radioterapia	16	**2.6%**
No corresponde	495	**80.9%**

Análisis de Resultados — Pregunta 3

Entre las 117 pacientes derivadas a Lima con etapa registrada: Confirmación del diagnóstico / biopsia representa el 41.9% (49 personas), Consulta con especialista el 17.1% (20 personas), Quimioterapia el 15.4% (18 personas), Radioterapia el 13.7% (16 personas), Cirugía el 8.5% (10 personas) y Estudios para determinar estadio el 3.4% (4 personas).



En el sector privado, entre quienes requirieron derivación a Lima (23 personas), las etapas de traslado fueron: Confirmación del diagnóstico / biopsia con 10 casos (43.5%), Radioterapia con 6 casos (26.1%), Consulta con especialista con 5 casos (21.7%) y Quimioterapia con 2 casos (8.7%).





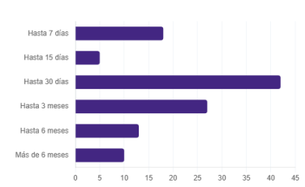
Entre las pacientes del sector público que requirieron traslado a Lima con etapa registrada (94 personas), la principal causa fue Confirmación del diagnóstico / biopsia con 39 casos (41.5%), seguida de Quimioterapia con 16 casos (17.0%), Consulta con especialista con 15 casos (16.0%), Radioterapia con 13 casos (10.6%) y Cirugía con 10 casos (10.6%).



Total Muestra: 612 personas

Tiempo de espera para atención en Lima

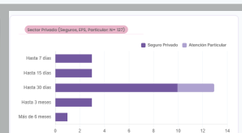
Tiempo transcurrido desde la derivación hasta recibir atención efectiva en Lima



Respuesta	N	%
Hasta 7 días	18	**2.9%**
Hasta 15 días	5	**0.8%**
Hasta 30 días	42	**6.9%**
Hasta 3 meses	27	**4.4%**
Hasta 6 meses	13	**2.1%**
Más de 6 meses	10	**1.6%**
No corresponde	497	**81.2%**

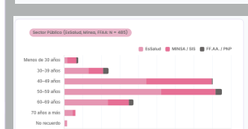
Análisis de Resultados — Pregunta 4

Entre las 115 pacientes derivadas a Lima con tiempo registrado: Hasta 30 días concentra el 36.5% (42 personas), Hasta 3 meses el 23.5% (27 personas), Hasta 7 días el 15.7% (18 personas), Hasta 6 meses el 11.3% (13 personas), Más de 6 meses el 8.7% (10 personas) y Hasta 15 días el 4.3% (5 personas).



En el sector privado, el 61.9% de las pacientes derivadas a Lima accedió en plazos breves: Hasta 30 días (13 pacientes, 61.9%) y Hasta 7 días (3 pacientes, 14.3%). Solo 3 pacientes esperaron hasta 3 meses.





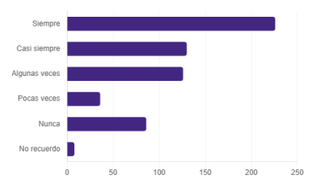
En el sector público, el diagnóstico se concentra en los rangos de 50–59 años con 171 pacientes (35.3%) y 40–49 años con 161 pacientes (33.2%), seguidos por 60–69 años (75, 15.5%). Las pacientes jóvenes menores de 40 años representan el 13.0% (63 mujeres).



Total Muestra: 612 personas

Información clara sobre el siguiente paso

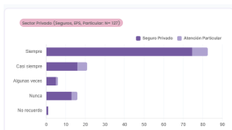
Frecuencia con la que recibió orientación clara sobre qué hacer en cada etapa de su atención



Respuesta	N	%
Siempre	226	**36.9%**
Casi siempre	130	**21.2%**
Algunas veces	126	**20.6%**
Pocas veces	36	**5.9%**
Nunca	86	**14.1%**
No recuerdo	8	**1.3%**

Análisis de Resultados — Pregunta 37

Sobre recibir información clara respecto al siguiente paso: Siempre en 226 personas (36.9%), Casi siempre en 130 personas (21.2%), Algunas veces en 126 personas (20.6%), Nunca en 86 personas (14.1%) y Pocas veces en 36 personas (5.9%).

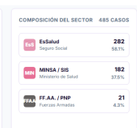


En el sector privado, la comunicación médica fue marcadamente superior: el 65.4% (83 pacientes) refirió que 'Siempre' recibió información clara y detallada, y el 16.5% 'Casi siempre'. Solo el 12.6% refirió 'Nunca'.





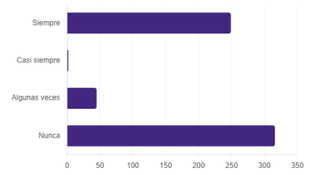
En cuanto a claridad de la información: En el sector público, solo el 29.5% (143 pacientes) refirió haber recibido 'Siempre' información clara y oportuna sobre el siguiente paso; el 47.2% la recibió 'Algunas veces' o 'Casi siempre', y un 14.8% indicó que 'Nunca' se le explicó.



Total Muestra: 612 personas

Indicación de tratamiento innovador no cubierto

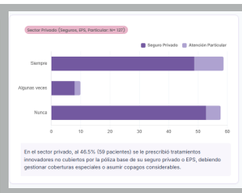
¿Le indicaron algún medicamento o tratamiento innovador que no estuviera cubierto por su seguro?



Respuesta	N	%
Siempre	249	**40.7%**
Casi siempre	2	**0.3%**
Algunas veces	45	**7.4%**
Nunca	316	**51.6%**

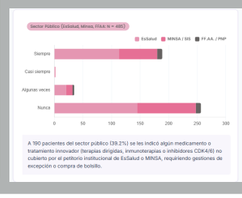
Análisis de Resultados — Pregunta 38

En cuanto a prescripción de tratamientos innovadores fuera de cobertura: 316 personas (51.6%) indicaron Nunca y 249 personas (40.7%) respondieron Siempre, evidenciando una brecha de cobertura farmacológica significativa.

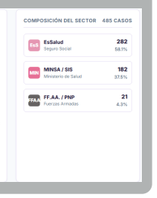


En el sector privado, al 46.5% (59 pacientes) se le prescribió tratamientos innovadores no cubiertos por la póliza base de su seguro privado o EPS, debiendo gestionar coberturas especiales o asumir copagos considerables.





A 190 pacientes del sector público (39.2%) se les indicó algún medicamento o tratamiento innovador (terapias dirigidas, inmunoterapias o inhibidores CDK4/6) no cubierto por el petitorio institucional de EsSalud o MINSA, requiriendo gestiones de excepción o compra de bolsillo.



35,9%

BARRERAS GEOGRÁFICAS

De las 320 encuestadas que residían fuera de Lima, 115 reportaron haber sido derivadas a Lima para recibir atención.

20,0%

DIFERENCIAS EN EL ESTADIO REPORTADO

106 de las 530 mujeres que registraron el estadio detectado señalaron que, al iniciar el tratamiento, les habían informado de un estadio más avanzado.

CONCLUSIONES

1

Las barreras aparecen en distintas etapas de la ruta, no únicamente al momento del diagnóstico

La experiencia de las pacientes muestra que las dificultades pueden comenzar al conseguir una cita y continuar durante la realización de exámenes, la entrega de resultados, las derivaciones y el inicio del tratamiento. El 59,5% de las participantes (364 de 612) reportó dificultades para realizarse los exámenes, mientras que el 60,6% (371 de 612) declaró retrasos en el inicio del tratamiento. Esto evidencia la importancia de evaluar la continuidad de la atención a lo largo de todo el proceso, y no solamente el acceso inicial al sistema de salud.

59,5 %

REPORTÓ DIFICULTADES PARA REALIZARSE LOS EXÁMENES

60,6 %

DECLARÓ RETRASOS EN EL INICIO DEL TRATAMIENTO

Total Muestra: 612 personas

Principal dificultad en el recorrido

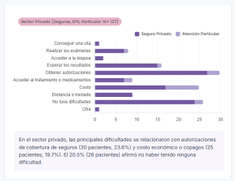
Problema más grave enfrentado a lo largo de todo el proceso de atención



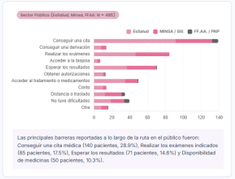
Respuesta	N	%
Conseguir una cita	141	23.0%
Conseguir una derivación	14	2.3%
Realizar los exámenes	93	15.2%
Acceder a la biopsia	9	1.5%
Esperar los resultados	87	14.2%
Obtener autorizaciones	43	7.0%
Acceder al tratamiento o medicamentos	59	9.6%
Costo	39	6.4%
Distancia o traslado	44	7.2%
No tuve dificultades	66	10.8%
Otra	17	2.8%

Análisis de Resultados — Pregunta 33

Las principales dificultades en el trayecto asistencial fueron: Conseguir una cita (141 personas, 23.0%), Realizar los exámenes (93 personas, 15.2%), Esperar los resultados (87 personas, 14.2%), No tuve dificultades (66 personas, 10.8%) y Acceder al tratamiento o medicamentos (59 personas, 9.6%). 17 personas (2.8%) señalaron otras dificultades o no especificaron.



En el sector privado, las principales dificultades se relacionaron con autorizaciones de cobertura de seguros (30 pacientes, 23.6%) y costo económico o copagos (25 pacientes, 19.7%). El 20.5% (26 pacientes) afirmó no haber tenido ninguna dificultad.



Las principales barreras reportadas a lo largo de la ruta en el público fueron: Conseguir una cita médica (140 pacientes, 28.9%), Realizar los exámenes indicados (85 pacientes, 17.5%), Esperar los resultados (71 pacientes, 14.6%) y Disponibilidad de medicinas (50 pacientes, 10.3%).

COMPOSICIÓN DEL SECTOR 127 CASOS

EPS	Seguro Privado	Pólizas y Empresas	110 86.6%
PAR	Atención Particular	Gasto Directo	17 13.4%

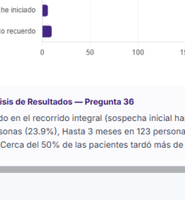
COMPOSICIÓN DEL SECTOR 485 CASOS

EsS	EsSalud	Seguro Social	282 58.1%
MIN	MINSA / SIS	Ministerio de Salud	182 37.5%
FFA	FF.AA. / PNP	Fuerzas Armadas	21 4.3%

Total Muestra: 612 personas

Acudió a sector privado por rapidez

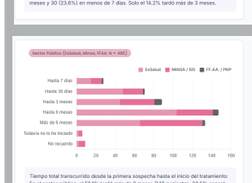
¿Tuvo que acudir a consultas, exámenes o procedimientos privados para celebrar su atención?



Respuesta	N	%
Sí	293	47.9%
No	310	50.7%
No recuerdo	9	1.5%

Análisis de Resultados — Pregunta 34

293 personas (47.9%) tuvieron que acudir al sector privado de forma complementaria para acelerar su atención, frente a 310 personas (50.7%) que no requirieron acudir a privados. 9 personas (1.5%) no lo recuerdan.



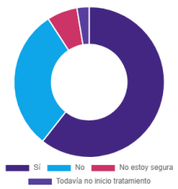
En el sector privado, el 52.0% (66 pacientes) también debió asumir pagos directos particulares fuera de su plan de seguro para acceder a procedimientos de mayor rapidez o tecnologías no cubiertas.

Casi la mitad de las pacientes del sector público (227 mujeres, 46.8%) tuvo que acudir de forma particular al sector privado y pagar de su bolsillo para acelerar consultas, ecografías y biopsias debido a la saturación de los hospitales públicos.

Total Muestra: 612 personas

Retraso de inicio de tratamiento por demoras

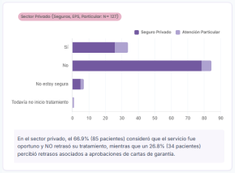
¿Considera que las demoras del sistema retrasaron el inicio de su tratamiento?



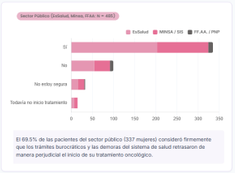
Respuesta	N	%
Sí	371	60.6%
No	185	30.2%
No estoy segura	40	6.5%
Todavía no inicio tratamiento	16	2.6%

Análisis de Resultados — Pregunta 35

371 personas (60.6%) consideraron que las demoras burocráticas y asistenciales del sistema retrasaron el inicio de su tratamiento, frente a 185 personas (30.2%) que no lo percibieron así.



En el sector privado, el 66.9% (85 pacientes) consideró que el servicio fue oportuno y NO retraso su tratamiento, mientras que un 26.8% (34 pacientes) percibió retrasos asociados a aprobaciones de cartas de garantía.

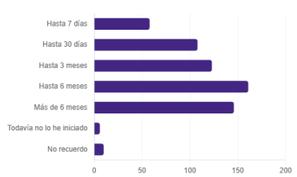


El 69.5% de las pacientes del sector público (337 mujeres) consideró firmemente que los trámites burocráticos y las demoras del sistema de salud retrasaron de manera perjudicial el inicio de su tratamiento oncológico.

Total Muestra: 612 personas

Tiempo total desde primera señal hasta tratamiento

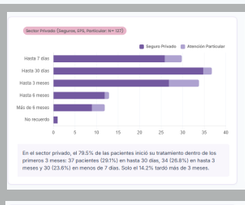
Tiempo total acumulado desde la detección del primer síntoma hasta el inicio del tratamiento



Respuesta	N	%
Hasta 7 días	58	9.5%
Hasta 30 días	108	17.6%
Hasta 3 meses	123	20.1%
Hasta 6 meses	161	26.3%
Más de 6 meses	146	23.9%
Todavía no lo he iniciado	6	1.0%
No recuerdo	10	1.6%

Análisis de Resultados — Pregunta 36

Pensando en el recorrido integral (sospecha inicial hasta inicio de tratamiento): Hasta 6 meses en 161 personas (26.3%), Más de 6 meses en 146 personas (23.9%), Hasta 3 meses en 123 personas (20.1%), Hasta 30 días en 108 personas (17.6%) y Hasta 7 días en 58 personas (9.5%). Cerca del 50% de las pacientes tardó más de 3 meses en iniciar tratamiento.



En el sector privado, el 79.5% de las pacientes inició su tratamiento dentro de los primeros 3 meses: 37 pacientes (29.1%) en hasta 30 días, 34 (26.8%) en hasta 3 meses y 30 (23.6%) en menos de 7 días. Solo el 14.2% tardó más de 3 meses.

Tiempo total transcurrido desde la primera sospecha hasta el inicio del tratamiento: En el sector público, el 58.1% tardó más de 3 meses (148 pacientes, 30.5% esperó de 3 a 6 meses; y 134 pacientes, 27.6% esperó más de 6 meses). Solo el 14.2% inició en menos de un mes.

COMPOSICIÓN DEL SECTOR 127 CASOS

EPS	Seguro Privado	Pólizas y Empresas	110 86.6%
PAR	Atención Particular	Gasto Directo	17 13.4%

COMPOSICIÓN DEL SECTOR 485 CASOS

EsS	EsSalud	Seguro Social	282 58.1%
MIN	MINSA / SIS	Ministerio de Salud	182 37.5%
FFA	FF.AA. / PNP	Fuerzas Armadas	21 4.3%

Observatorio de Cáncer | POR UN PERÚ SIN CÁNCER.

Total Muestra: 612 personas

Detección inicial de la señal

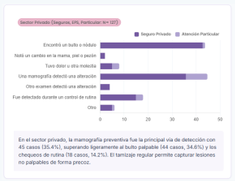
¿Cómo se detectó la primera señal o síntoma de alerta?



Respuesta	N	%
Notó un cambio en la mama, piel o pezón	33	5.4%
Tuvo secreción por el pezón	10	1.6%
Tuvo dolor u otra molestia	27	4.4%
Una mamografía detectó una alteración	178	29.1%
Una ecografía detectó una alteración	11	1.8%
Otro examen detectó una alteración	4	0.7%
Fue detectado durante un control de rutina	48	7.8%
Otro	28	4.6%
No recuerdo	2	0.3%

Análisis de Resultados — Pregunta 5

El hallazgo físico de un nódulo o bulto fue la principal vía de sospecha (271 personas, 44.3%), seguido de detección por mamografía (178 personas, 29.1%), control de rutina (48 personas, 7.8%), cambios en mama, piel o pezón (33 personas, 5.4%) y dolor u otra molestia (27 personas, 4.4%). 2 personas (0.3%) no recuerdan el síntoma inicial.



En el sector privado, la mamografía preventiva fue la principal vía de detección con 45 casos (35.4%), superando ligeramente al bulto palpable (44 casos, 34.6%) y los chequeos de rutina (18 casos, 14.2%). El tamizaje regular permite capturar lesiones no palpables de forma precoz.



En el sector público, la primera señal de alarma fue predominantemente un hallazgo físico por bulto o nódulo palpable con 227 casos (46.8%), mientras que la mamografía preventiva solo detectó al 27.4% (133 casos) y los controles de rutina el 6.4% (31 casos), evidenciando un diagnóstico tardío por falta de tamizaje temprano.

COMPOSICIÓN DEL SECTOR 127 CASOS

EPS	Seguro Privado	Pólizas y Empresas	110 86.6%
PAR	Atención Particular	Gasto Directo	17 13.4%

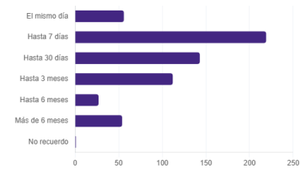
COMPOSICIÓN DEL SECTOR 485 CASOS

EsS	EsSalud	Seguro Social	282 58.1%
MIN	MINSA / SIS	Ministerio de Salud	182 37.5%
FFA	FF.AA. / PNP	Fuerzas Armadas	21 4.3%

Total Muestra: 612 personas

Tiempo hasta buscar arención médica

Tiempo que tomó la paciente desde que notó la señal hasta acudir o pedir cita médica



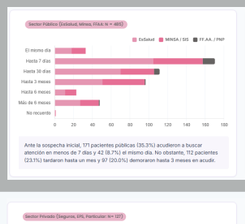
Respuesta	N	%
El mismo día	56	9.2%
Hasta 7 días	219	35.8%
Hasta 30 días	143	23.4%
Hasta 3 meses	112	18.3%
Hasta 6 meses	27	4.4%
Más de 6 meses	54	8.8%
No recuerdo	1	0.2%

Análisis de Resultados — Pregunta 6

La búsqueda de atención inicial fue mayormente rápida: 219 personas (35.8%) buscaron atención en Hasta 7 días y 56 personas (9.2%) El mismo día. Por otro lado, 143 personas (23.4%) esperaron Hasta 30 días, 112 personas (18.3%) Hasta 3 meses, 27 personas (4.4%) Hasta 6 meses y 54 personas (8.8%) Más de 6 meses. 1 persona (0.2%) no recuerda el tiempo transcurrido.



En el sector privado, 48 pacientes (37.8%) acudieron dentro de los primeros 7 días y 23 (18.1%) el mismo día. Un 24.4% (31 pacientes) esperó hasta un mes y 15 (11.8%) tardó hasta 3 meses.



Ante la sospecha inicial, 171 pacientes públicos (35.3%) acudieron a buscar atención en menos de 7 días y 42 (8.7%) el mismo día. No obstante, 112 pacientes (23.1%) tardaron hasta un mes y 97 (20.0%) demoraron hasta 3 meses en acudir.

COMPOSICIÓN DEL SECTOR 127 CASOS

EPS	Seguro Privado	Pólizas y Empresas	110 86.6%
PAR	Atención Particular	Gasto Directo	17 13.4%

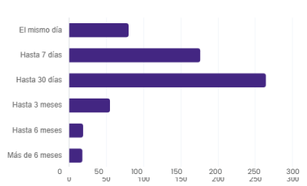
COMPOSICIÓN DEL SECTOR 485 CASOS

EsS	EsSalud	Seguro Social	282 58.1%
MIN	MINSA / SIS	Ministerio de Salud	182 37.5%
FFA	FF.AA. / PNP	Fuerzas Armadas	21 4.3%

Total Muestra: 612 personas

Tiempo hasta la primera consulta médica

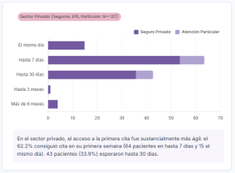
Tiempo de espera desde que solicitó la cita hasta ser evaluada en la primera consulta



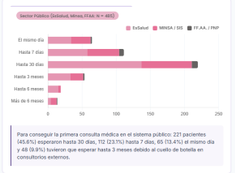
Respuesta	N	%
El mismo día	80	13.1%
Hasta 7 días	176	28.8%
Hasta 30 días	264	43.1%
Hasta 3 meses	55	9.0%
Hasta 6 meses	19	3.1%
Más de 6 meses	18	2.9%

Análisis de Resultados — Pregunta 7

Para lograr la primera consulta médica: 264 personas (43.1%) esperaron Hasta 30 días, 176 personas (28.8%) Hasta 7 días, 80 personas (13.1%) El mismo día, 55 personas (9.0%) Hasta 3 meses y 37 personas (6.0%) más de 3 meses.



En el sector privado, el acceso a la primera cita fue sustancialmente más ágil: el 62.2% consiguió cita en su primera semana (64 pacientes en hasta 7 días y 15 el mismo día). 43 pacientes (33.9%) esperaron hasta 30 días.



Para conseguir la primera consulta médica en el sistema público: 221 pacientes (45.6%) esperaron hasta 30 días, 112 (23.1%) hasta 7 días, 69 (13.4%) el mismo día y 48 (9.9%) tuvieron que esperar hasta 3 meses debido al cuello de botella en consultorios externos.

COMPOSICIÓN DEL SECTOR 127 CASOS

EPS	Seguro Privado	Pólizas y Empresas	110 86.6%
PAR	Atención Particular	Gasto Directo	17 13.4%

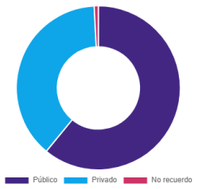
COMPOSICIÓN DEL SECTOR 485 CASOS

EsS	EsSalud	Seguro Social	282 58.1%
MIN	MINSA / SIS	Ministerio de Salud	182 37.5%
FFA	FF.AA. / PNP	Fuerzas Armadas	21 4.3%

Total Muestra: 612 personas

Tipo de establecimiento de la primera consulta

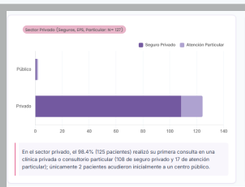
Sector del centro de salud donde se realizó la primera consulta médica



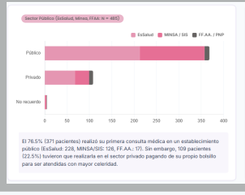
Respuesta	N	%
Público	373	60.9%
Privado	234	38.2%
No recuerdo	5	0.8%

Análisis de Resultados — Pregunta 8

373 personas (60.9%) tuvieron su primera consulta en un centro Público, mientras que 234 personas (38.2%) acudieron al sector Privado y 5 personas no recuerdan.



En el sector privado, el 98.4% (125 pacientes) realizó su primera consulta en una clínica privada o consultorio particular (108 de seguro privado y 17 de atención particular); únicamente 2 pacientes acudieron inicialmente a un centro público.



El 76.5% (371 pacientes) realizó su primera consulta médica en un establecimiento público (EsSalud: 228, MINSA/SIS: 126, FF.AA.: 17). Sin embargo, 109 pacientes (23.5%) tuvieron que realizarla en el sector privado pagando de su propio bolsillo para ser atendidas con mayor celeridad.

COMPOSICIÓN DEL SECTOR 127 CASOS

EPS	Seguro Privado	Pólizas y Empresas	110 86.6%
PAR	Atención Particular	Gasto Directo	17 13.4%

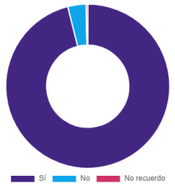
COMPOSICIÓN DEL SECTOR 485 CASOS

EsS	EsSalud	Seguro Social	282 58.1%
MIN	MINSA / SIS	Ministerio de Salud	182 37.5%
FFA	FF.AA. / PNP	Fuerzas Armadas	21 4.3%

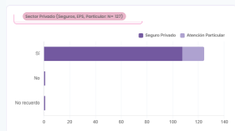
Total Muestra: 612 personas

Solicitud de exámenes de mama

¿En la primera consulta le solicitaron exámenes de diagnóstico mamario?

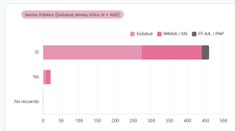


Respuesta	N	%
Sí	588	**96.1%**
No	22	**3.6%**
No recuerdo	2	**0.3%**



En el sector privado, al 98.4% (125 pacientes) se le prescribieron exámenes de mama durante su primera consulta médica.





En la primera consulta médica, al 95.5% (463 pacientes públicas) se le solicitó de inmediato exámenes complementarios de mama (mamografía, ecografía o resonancia).



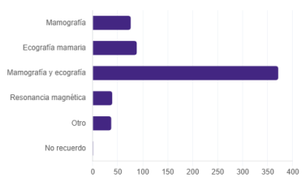
Análisis de Resultados — Pregunta 9

A 588 personas (96.1% del total) sí se les indicó exámenes mamarios en su primera evaluación, reflejando una alta tasa de sospecha e indicación oportuna.

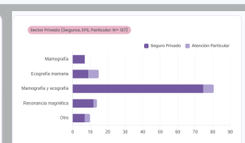
Total Muestra: 612 personas

Exámenes solicitados

Estudios de imagen indicados para evaluar la sospecha mamaria

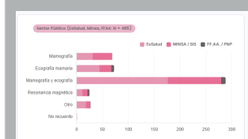


Respuesta	N	%
Mamografía	76	**12.4%**
Ecografía mamaria	88	**14.4%**
Mamografía y ecografía	371	**60.6%**
Resonancia magnética	39	**6.4%**
Otro	37	**6.0%**
No recuerdo	1	**0.2%**



En el privado, la combinación de mamografía y ecografía alcanzó el 63.8% (81 casos), mientras que la resonancia magnética tuvo una tasa mayor de uso (14 casos, 11.0%) y la ecografía sola representó el 11.8% (15 casos).





El estudio más prescrito en el público fue la combinación de mamografía y ecografía en 290 pacientes (59.8%), seguida por ecografía mamaria exclusiva (73, 15.1%), mamografía sola (69, 14.2%) y resonancia magnética (15, 3.1%).



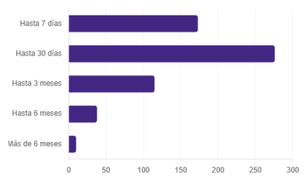
Análisis de Resultados — Pregunta 10

El estudio más solicitado fue Mamografía y ecografía de manera combinada (371 personas, 60.6%), seguido de Ecografía mamaria sola (88 personas, 14.4%), Mamografía sola (76 personas, 12.4%) y Resonancia magnética (39 personas, 6.4%).

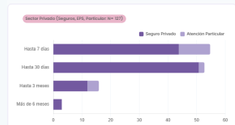
Total Muestra: 612 personas

Tiempo hasta realizar el examen

Demora desde la orden médica hasta la realización efectiva del estudio de imagen



Respuesta	N	%
Hasta 7 días	173	**28.3%**
Hasta 30 días	276	**45.1%**
Hasta 3 meses	115	**18.8%**
Hasta 6 meses	38	**6.2%**
Más de 6 meses	10	**1.6%**



En el sector privado, el 85.0% de las pacientes se realizó los exámenes dentro del primer mes: 55 pacientes (43.3%) en menos de 7 días y 53 (41.7%) en hasta 30 días. Solo 16 esperaron hasta 3 meses.





Para realizarse los exámenes solicitados en el sector público, el 46.0% (223 pacientes) esperó hasta 30 días y el 20.4% (99 pacientes) esperó hasta 3 meses. Solo el 24.3% (118 pacientes) logró realizárselos en 7 días.



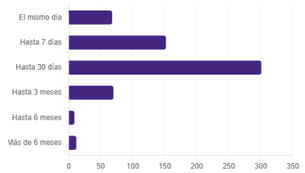
Análisis de Resultados — Pregunta 11

Para la toma efectiva de exámenes de imagen: 276 personas (45.1%) esperaron Hasta 30 días, 173 personas (28.3%) Hasta 7 días, 115 personas (18.8%) Hasta 3 meses y 48 personas (7.8%) esperaron más de 3 meses.

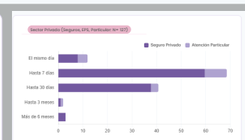
Total Muestra: 612 personas

Tiempo de espera para atención en Lima

Tiempo transcurrido desde la derivación hasta recibir atención efectiva en Lima

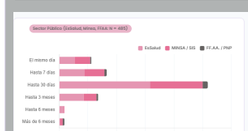


Respuesta	N	%
El mismo día	68	**11.1%**
Hasta 7 días	152	**24.8%**
Hasta 30 días	301	**49.2%**
Hasta 3 meses	70	**11.4%**
Hasta 6 meses	9	**1.5%**
Más de 6 meses	12	**2.0%**



En el sector privado, la entrega de resultados fue significativamente más rápida: el 54.3% (69 pacientes) los recibió en menos de 7 días y el 9.4% (12 pacientes) el mismo día. El 32.3% (41) los tuvo en hasta 30 días.





El tiempo hasta recibir los resultados del examen en el sector público tardó hasta 30 días en 260 pacientes (53.6%) y hasta 3 meses en 68 pacientes (14.0%). Solo el 17.1% (83) obtuvo el informe en menos de 7 días.



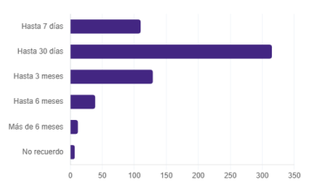
Análisis de Resultados — Pregunta 12

La entrega de resultados de imagen tomó: Hasta 30 días en 301 personas (49.2%), Hasta 7 días en 152 personas (24.8%), Hasta 3 meses en 70 personas (11.4%), El mismo día en 68 personas (11.1%) y más de 3 meses en 21 personas (3.4%).

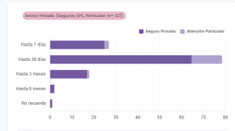
Total Muestra: 612 personas

Tiempo de indicación a inicio de tatamiento

Espera desde que se indicó el tratamiento hasta empezar efectivamente la terapia

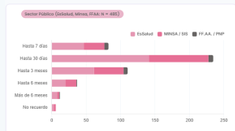


Respuesta	N	%
Hasta 7 días	110	**18.0%**
Hasta 30 días	315	**51.5%**
Hasta 3 meses	129	**21.1%**
Hasta 6 meses	39	**6.4%**
Más de 6 meses	12	**2.0%**
No recuerdo	7	**1.1%**



En el sector privado, al 83.5% recibió indicación terapéutica en menos de un mes: 79 pacientes (62.2%) en hasta 30 días y 27 (21.3%) en menos de 7 días. Solo 18 pacientes esperaron hasta 3 meses.





Desde la confirmación diagnóstica hasta recibir la indicación formal del oncólogo: 236 pacientes públicas (48.7%) esperaron hasta 30 días, 111 (22.9%) hasta 3 meses, 83 (17.1%) hasta 7 días y 34 (7.0%) esperaron más de 3 meses.



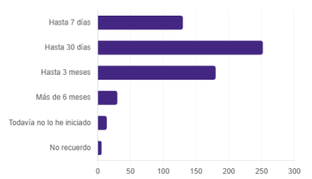
Análisis de Resultados — Pregunta 29

Desde el diagnóstico hasta la indicación terapéutica transcurrieron: Hasta 30 días en 315 personas (51.5%), Hasta 3 meses en 129 personas (21.1%), Hasta 7 días en 110 personas (18.0%) y más de 3 meses en 51 personas (8.3%).

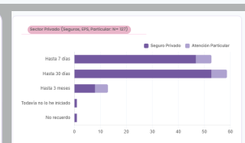
Total Muestra: 612 personas

Tiempo de indicación a inicio de tratamiento

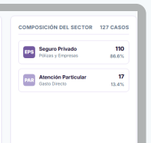
Espera desde que se indicó el tratamiento hasta empezar efectivamente la terapia

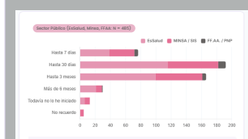


Respuesta	N	%
Hasta 7 días	130	**21.2%**
Hasta 30 días	252	**41.2%**
Hasta 3 meses	180	**29.4%**
Más de 6 meses	30	**4.9%**
Todavía no lo he iniciado	14	**2.3%**
No recuerdo	6	**1.0%**



En el sector privado, el 88.2% inició su tratamiento en menos de un mes: 59 pacientes (46.5%) en hasta 30 días y 53 pacientes (41.7%) en menos de 7 días. Solo 13 pacientes esperaron hasta 3 meses.





Desde la indicación médica hasta el inicio efectivo de la terapia (primera sesión de quimio o fecha de cirugía): 193 pacientes públicas (39.8%) esperaron hasta 30 días, 167 (34.4%) tardaron hasta 3 meses, y 35 pacientes (7.2%) esperaron de 3 a más de 6 meses.



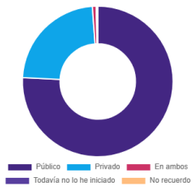
Análisis de Resultados — Pregunta 30

Desde la prescripción del tratamiento hasta su inicio efectivo: 252 personas (41.2%) esperaron Hasta 30 días, 180 personas (29.4%) Hasta 3 meses, 130 personas (21.2%) Hasta 7 días y 30 personas (4.9%) Más de 6 meses. 14 aún no lo inician.

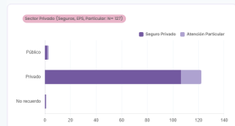
Total Muestra: 612 personas

Lugar donde inició el tratamiento

Sector del establecimiento donde recibió su primer tratamiento oncológico

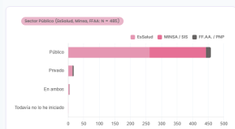


Respuesta	N	%
Público	464	**75.8%**
Privado	141	**23.0%**
En ambos	5	**0.8%**
Todavía no lo he iniciado	1	**0.2%**
No recuerdo	1	**0.2%**



El 96.9% (123 pacientes privadas) inició su tratamiento en centros oncológicos privados o clínicas con cobertura de su seguro; únicamente 3 pacientes acudieron a centros públicos.





El 95.1% (461 pacientes públicas) inició efectivamente su tratamiento en hospitales públicos (EsSalud: 270, MINSA/INEN: 172, FF.AA.: 18); 18 pacientes (3.7%) debieron iniciarlo en clínicas privadas.



Análisis de Resultados — Pregunta 31

El 75.8% (464 personas) inició tratamiento en el sector Público, mientras que el 23.0% (141 personas) lo inició en el sector Privado y 5 personas en ambos sectores.

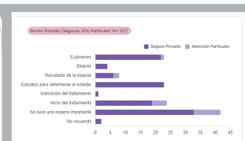
Total Muestra: 612 personas

Etapa con mayor tiempo de espera

Fase del recorrido donde la paciente experimentó el mayor cuello de botella

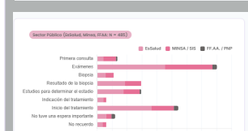


Respuesta	N	%
Primera consulta	27	**4.4%**
Exámenes	184	**30.1%**
Biopsia	26	**4.2%**
Resultado de la biopsia	67	**10.9%**
Estudios para determinar el estadio	82	**13.4%**
Indicación del tratamiento	13	**2.1%**
Inicio del tratamiento	133	**21.7%**
No tuve una espera importante	66	**10.8%**
No recuerdo	14	**2.3%**



En el sector privado, la respuesta predominante fue 'No tuve una espera importante' con 42 pacientes (33.1%), seguida por Inicio del tratamiento (24 menciones, 18.9%) y Exámenes diagnósticos (23 menciones, 18.1%).





Las etapas con mayor tiempo de espera percibido en el sector público fueron: Exámenes de diagnóstico (161 menciones, 33.2%), Inicio efectivo del tratamiento (109 menciones, 22.5%) y Estudios para determinar estadio (58 menciones, 12.2%).



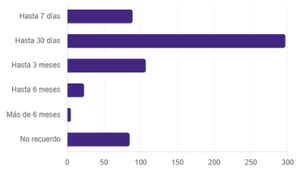
Análisis de Resultados — Pregunta 32

Las etapas con mayor tiempo de espera reportadas fueron: Exámenes mamarios (184 personas, 30.1%), Inicio del tratamiento (133 personas, 21.7%), Estudios para definir estadio (82 personas, 13.4%) y Resultado de la biopsia (67 personas, 10.9%).

Total Muestra: 612 personas

Tiempo de estudios para determinar estadio

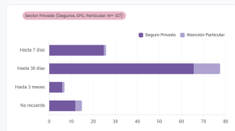
Tiempo que tomaron las tomografías, gammagrafías y estudios de extensión



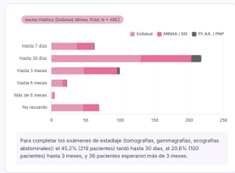
Respuesta	N	%
Hasta 7 días	89	**14.5%**
Hasta 30 días	297	**48.5%**
Hasta 3 meses	107	**17.5%**
Hasta 6 meses	23	**3.8%**
Más de 6 meses	5	**0.8%**
No recuerdo	85	**13.9%**
No corresponde	6	**1.0%**

Análisis de Resultados — Pregunta 25

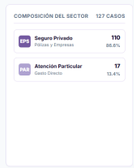
Entre las 606 pacientes que realizaron estudios de estadificación: el 49.0% (297 personas) demoró Hasta 30 días, el 17.7% (107 personas) Hasta 3 meses y el 14.7% (89 personas) Hasta 7 días. 85 personas (14.0%) no recuerdan el lapso exacto.

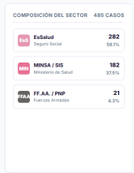


En el sector privado, el 81.9% de los estudios de estadio concluyó dentro del primer mes: 78 pacientes (61.4%) en hasta 30 días y 26 (20.5%) en menos de una semana.



Para completar los exámenes de estadaje (tomografías, gammagrafías, ecografías abdominales): el 45.2% (218 pacientes) tardó hasta 30 días, el 20.6% (100 pacientes) hasta 3 meses, y 36 pacientes esperaron más de 3 meses.

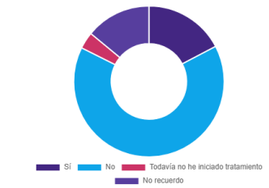




Total Muestra: 612 personas

Estadio diferente al inicio de tratamiento

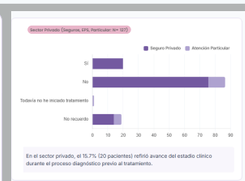
¿Cambió o pregresó el estadio de la enfermedad para cuando logró iniciar el tratamiento?



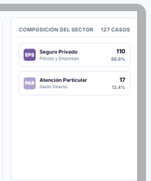
Respuesta	N	%
No	398	**65.0%**
Todavía no he iniciado tratamiento	22	**3.6%**
No recuerdo	86	**14.1%**

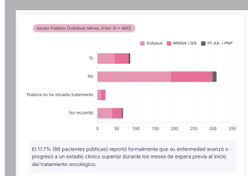
Análisis de Resultados — Pregunta 26

398 personas (65.0%) mantuvieron el mismo estadio inicial, mientras que 106 personas (17.3%) reportaron que su estadio cambió o progresó antes de iniciar tratamiento. 86 no recuerdan y 22 aún no inician terapia.



En el sector privado, el 15.7% (20 pacientes) refirió avance del estadio clínico durante el proceso diagnóstico previo al tratamiento.





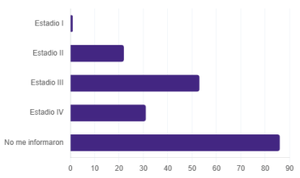
El 17.7% (86 pacientes públicas) reportó formalmente que su enfermedad avanzó o progresó a un estadio clínico superior durante los meses de espera previa al inicio del tratamiento oncológico.



Total Muestra: 612 personas

Estado informado al inicio de tratamiento

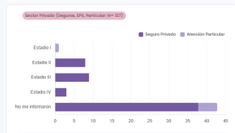
Estadio reasignado al comenzar el tratamiento oncológico



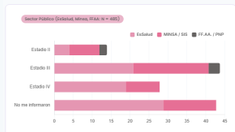
Respuesta	N	%
Estadio I	1	**0.2%**
Estadio II	22	**3.6%**
Estadio III	53	**8.7%**
Estadio IV	31	**5.1%**
No me informaron	86	**14.1%**
No corresponde	419	**68.5%**

Análisis de Resultados — Pregunta 27

Entre las 193 pacientes a quienes se les informó un estadio diferente al iniciar tratamiento: el 44.6% (86 personas) indicó que no le especificaron el nuevo estadio. Entre quienes lo conocieron, predominó Estadio III (53 personas, 27.5%), Estadio IV (31 personas, 16.1%) y Estadio II (22 personas, 11.4%).



En el sector privado, entre las pacientes que refirieron un estadio redefinido al inicio, se registraron 9 casos en Estadio III y 7 casos en Estadio IV metastásico.



Entre quienes reportaron un estadio informado al inicio del tratamiento médico en el sector público, destacan 44 casos en Estadio III (9.1%), 28 en Estadio IV con metástasis (5.8%) y 14 en Estadio II.





Total Muestra: 612 personas

Tratamiento indicado inicialmente

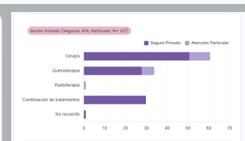
Primera modalidad terapéutica indicada por el médico tratante



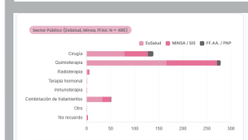
Respuesta	N	%
Cirugía	201	**32.8%**
Quimioterapia	315	**51.5%**
Radioterapia	7	**1.1%**
Terapia hormonal	1	**0.2%**
Inmunoterapia	1	**0.2%**
Combinación de tratamientos	82	**13.4%**
Otro	1	**0.2%**
No recuerdo	4	**0.7%**

Análisis de Resultados — Pregunta 28

La Quimioterapia fue el primer tratamiento indicado en 315 personas (51.5%), seguida de Cirugía en 201 personas (32.8%) y Combinación de tratamientos en 82 personas (13.4%).



En el sector privado, la Cirugía fue la indicación inicial más frecuente con 61 pacientes (48.0%), superando a la Quimioterapia (34 pacientes, 26.8%) y Tratamiento combinado (30 pacientes, 23.6%). Lo que guarda estricta correlación con la alta detección en etapas tempranas Estadio I y II.



En el sector público, la Quimioterapia fue el primer tratamiento indicado de manera mayoritaria con 281 pacientes (57.9%), seguida de la Cirugía con 145 pacientes (28.9%) y Combinación terapéutica con 52 pacientes (10.7%). La alta tasa de quimioterapia neoadyuvante refleja la necesidad de reducir tumores avanzados previos a operar.

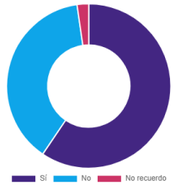




Total Muestra: 612 personas

Dificultad para realizar exámenes

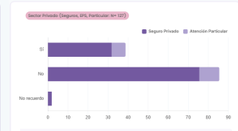
¿Tuvo alguna dificultad o barrera para poder realizarse los exámenes de mama?



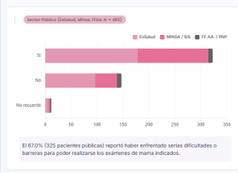
Respuesta	N	%
Sí	364	**59.5%**
No	234	**38.2%**
No recuerdo	14	**2.3%**

Análisis de Resultados — Pregunta 13

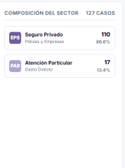
364 personas (59.5%) reportaron haber enfrentado dificultades para realizarse los exámenes mamarios, frente a 234 (38.2%) que no tuvieron inconvenientes.

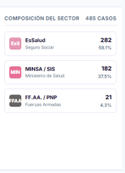


Por el contrario, en el sector privado el 67.7% (86 pacientes) afirmó no haber tenido dificultades para realizar sus estudios de imagen; el 30.7% (39) reportó algún inconveniente administrativo o de cobertura.



El 67.0% (325 pacientes públicas) reportó haber enfrentado serias dificultades o barreras para poder realizarse los exámenes de mama indicados.





Total Muestra: 612 personas

Principal dificultad en exámenes

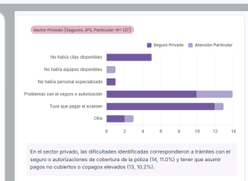
Obstáculo principal reportado por las personas que tuvieron problemas con sus exámenes



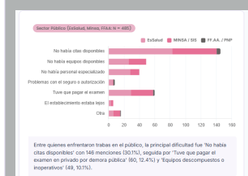
Respuesta	N	%
No había citas disponibles	151	**24.7%**
No había equipos disponibles	50	**8.2%**
No había personal especializado	41	**6.7%**
Problemas con el seguro o autorización	22	**3.6%**
Tuve que pagar el examen	73	**11.9%**
El establecimiento estaba lejos	6	**1.0%**
Otra	19	**3.1%**
No corresponde	250	**40.8%**

Análisis de Resultados — Pregunta 14

Entre las 362 personas que enfrentaron dificultades en sus exámenes: No había citas disponibles fue la principal barrera (151 personas, 41.7%), seguida de Tuve que pagar el examen (73 personas, 20.2%), No había equipos disponibles (50 personas, 13.8%) y No había personal especializado (41 personas, 11.3%).

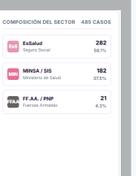


En el sector privado, las dificultades identificadas correspondieron a trámites con el seguro o autorizaciones de cobertura de la póliza (14, 11.0%) y tener que asumir pagos no cubiertos o copagos elevados (13, 10.2%).



Entre quienes enfrentaron trabas en el público, la principal dificultad fue 'No había citas disponibles' con 146 menciones (30.1%), seguida por 'Tuve que pagar el examen en privado por demora pública' (60, 12.4%) y 'Equipos descompuestos o inoperativos' (48, 9.7%).

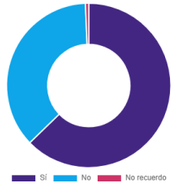




Total Muestra: 612 personas

Derivación a otro establecimeinto o especialista

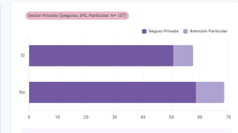
¿Fue derivado a otro centro de mayor complejidad o a un médico especialista tras los exámenes?



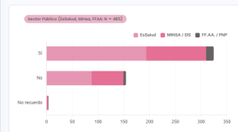
Respuesta	N	%
Sí	384	**62.7%**
No	224	**36.6%**
No recuerdo	4	**0.7%**

Análisis de Resultados — Pregunta 15

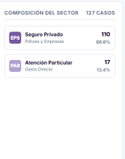
384 personas (62.7%) requirieron derivación a un especialista o centro de mayor complejidad tras los exámenes, mientras que 224 (36.6%) continuaron en el mismo centro y 4 personas (0.7%) no lo recuerdan.



En el sector privado, la mayoría de pacientes (69, 54.3%) resolvió su atención con el mismo especialista o clínica sin necesidad de derivación externa; un 45.7% (58 pacientes) fue derivada a mastólogos u oncólogos de referencia.



El 67.2% (326 pacientes públicas) debió ser derivada a otro establecimiento o especialista tras sus exámenes iniciales para continuar con la confirmación diagnóstica, reflejando fragmentación en el primer y segundo nivel asistencial.





Total Muestra: 612 personas

Tiempo de espera tras derivación

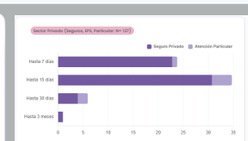
Tiempo que demoró en ser atendida una vez derivada al especialista o nuevo establecimiento



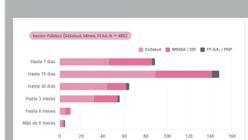
Respuesta	N	%
Hasta 7 días	113	**18.5%**
Hasta 15 días	184	**30.1%**
Hasta 30 días	71	**11.6%**
Hasta 3 meses	57	**9.3%**
Hasta 6 meses	10	**1.6%**
Más de 6 meses	5	**0.8%**
No corresponde	172	**28.1%**

Análisis de Resultados — Pregunta 16

Entre las 440 pacientes que requirieron derivación médica: el 41.8% (184 personas) esperó Hasta 15 días, el 25.7% (113 personas) Hasta 7 días, el 16.1% (71 personas) Hasta 30 días y el 13.0% (57 personas) Hasta 3 meses. Un 3.4% (15 personas) esperó más de 3 meses.



En el sector privado, la atención tras la derivación se concretó de manera oportuna: el 39.8% (54 pacientes) fue atendida en menos de 7 días y el 18.7% (23 pacientes) en hasta 15 días.



Tras la derivación médica en el público, el tiempo de espera para ser evaluada por el nuevo especialista fue: Hasta 15 días en 149 pacientes (30.7%), Hasta 7 días en 89 (18.4%), Hasta 30 días en 65 (13.4%) y Hasta 3 meses en 31 (6.4%).

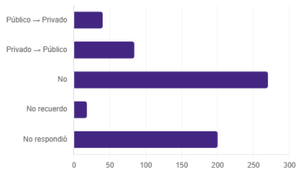




Total Muestra: 612 personas

Cambio de sistema de atención en derivación

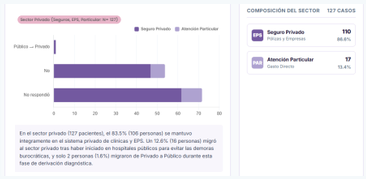
¿Hubo transición entre el sector público y el sector privado durante la derivación?

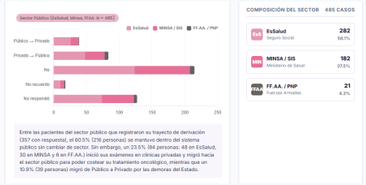


Respuesta	N	%
Público → Privado	40	6.5%
Privado → Público	84	13.7%
No	270	44.1%
No recuerdo	18	2.9%
No respondió	200	32.7%

Análisis de Resultados — Pregunta 17

Entre las 412 pacientes derivadas que registraron su trayecto: el 65.5% (270 personas) permaneció en el mismo subsistema de salud, mientras que el 20.4% (84 personas) migró de Privado a Público para continuar su tratamiento y el 9.7% (40 personas) pasó de Público a Privado.





Total Muestra: 612 personas

Indicación de biopsia

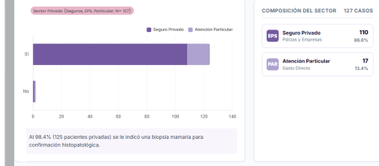
¿Se le indicó la realización de una biopsia para confirmar el diagnóstico?



Respuesta	N	%
Sí	602	98.4%
No	10	1.6%

Análisis de Resultados — Pregunta 18

A 602 personas (98.4%) se les indicó biopsia para confirmación histopatológica, constituyendo el estándar diagnóstico casi universal en el recorrido.





Total Muestra: 612 personas

Tiempo hasta realizar la biopsia

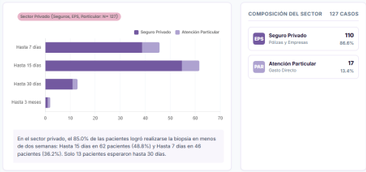
Demora desde que el médico indicó la biopsia hasta que se realizó el procedimiento

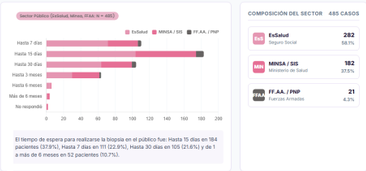


Respuesta	N	%
Hasta 7 días	157	25.7%
Hasta 15 días	246	40.2%
Hasta 30 días	118	19.3%
Hasta 3 meses	66	10.8%
Hasta 6 meses	6	1.0%
Más de 6 meses	4	0.7%
No respondió	2	0.3%
No corresponde	13	2.1%

Análisis de Resultados — Pregunta 19

Entre las 603 pacientes que realizaron biopsia: el 41.2% (246 personas) accedió al procedimiento en Hasta 15 días, el 26.3% (157 personas) en Hasta 7 días, el 19.8% (118 personas) en Hasta 30 días, el 11.1% (66 personas) en Hasta 3 meses, el 1.0% (6 personas) en Hasta 6 meses y el 0.7% (4 personas) en Más de 6 meses.

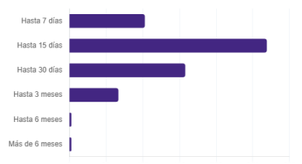




Total Muestra: 612 personas

Tiempo hasta resultado de biopsia

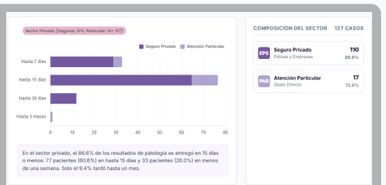
Tiempo desde la toma de biopsia hasta la entrega del resultado anatomopatológico

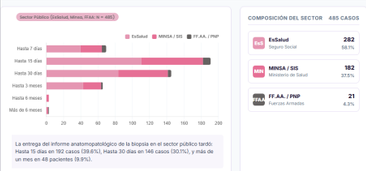


Respuesta	N	%
Hasta 7 días	103	16.8%
Hasta 15 días	269	44.0%
Hasta 30 días	158	25.8%
Hasta 3 meses	67	10.9%
Hasta 6 meses	3	0.5%
Más de 6 meses	3	0.5%
No corresponde	9	1.5%

Análisis de Resultados — Pregunta 20

Entre las 603 pacientes que realizaron biopsia: la entrega del informe anatomopatológico tomó Hasta 15 días en el 44.6% (269 personas), Hasta 30 días en el 26.2% (158 personas), Hasta 7 días en el 17.1% (103 personas) y Hasta 3 meses en el 11.1% (67 personas).

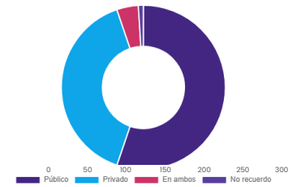




Total Muestra: 612 personas

Establecimiento de la biopsia

Sector del establecimiento donde se efectuó la biopsia

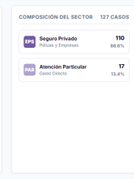


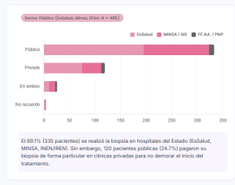
Respuesta	N	%
Público	338	55.2%
Privado	242	39.5%
En ambos	26	4.2%
No recuerdo	6	1.0%

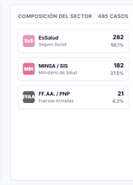
Análisis de Resultados — Pregunta 21

338 personas (55.2%) se realizaron la biopsia en el sector Público, 242 personas (39.5%) en el sector Privado, 26 personas (4.2%) en ambos sectores y 6 personas (1.0%) no lo recuerdan.





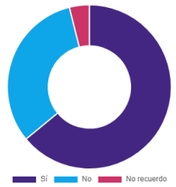




Total Muestra: 612 personas

Información sobre subtipo de cáncer

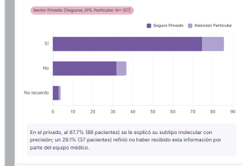
¿Le informaron qué subtipo molecular o inmunohistoquímico de cáncer de mama tenía?

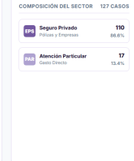


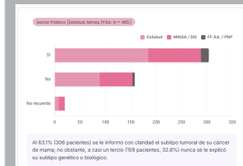
Respuesta	N	%
No	196	32.0%
No recuerdo	24	3.9%

Análisis de Resultados — Pregunta 22

A 392 personas (64.1%) se les informó su subtipo molecular tumoral, mientras que 196 (32.0%) indicaron que no se les informó y 24 no lo recuerdan.









Total Muestra: 612 personas

Subtipo de cáncer informado

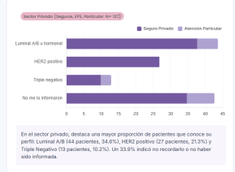
Subtipo biológico reportado por las pacientes que recibieron esta información

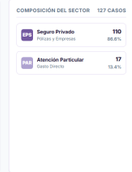


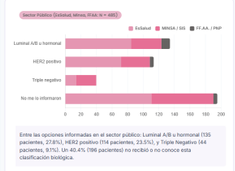
Respuesta	N	%
Luminal A/B u hormonal	179	29.2%
HER2 positivo	141	23.0%
Triple negativo	53	8.7%
No me lo informaron	239	39.1%

Análisis de Resultados — Pregunta 23

Entre las pacientes con subtipo informado: Luminal A/B u hormonal concentra 179 personas (29.2%), HER2 positivo 141 personas (23.0%) y Triple negativo 53 personas (8.7%). 239 personas (39.1%) no tuvieron información o no se les especificó el subtipo biológico.





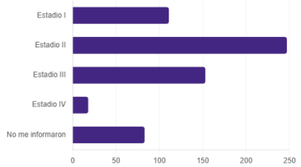




Total Muestra: 612 personas

Estadio detectado

Estadio clínico en el que se detectó inicialmente el cáncer de mama



Respuesta	N	%
Estadio I	111	18.1%
Estadio II	247	40.4%
Estadio III	153	25.0%
Estadio IV	18	2.9%
No me informaron	83	13.6%

Análisis de Resultados — Pregunta 24

Predominan los diagnósticos en estadios intermedios y avanzados: Estadio II con 247 personas (40.4%) y Estadio III con 153 personas (25.0%). En estadio temprano (Estadio I) se detectó a 111 personas (18.1%), en Estadio IV a 18 personas (2.9%) y a 83 personas (13.6%) no se les informó el estadio clínico inicial.

